

44-Développement des Extrémités

Ça se passe ici, le cerveau. Ça se passe ici, dans le tube digestif. Mais là, on va rajouter après la rotation, comme ceci. Pour mes membres, OK ? Même chose pour mes membres inférieurs. Ça se passe en même temps, ici. Ça se passe en même temps là, et ça se passe en même temps là. Une tendinite peut être l'expression d'un déficit de rotation de ton péritoine, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un problème de bras, ici. Je ne sais pas, il a un problème au niveau tendineux, etc. Et on dit que c'est une tendinite au niveau du poignet. Quelqu'un me dit, tiens, c'est bizarre, je n'ai jamais joué au tennis. J'étais chez ma salle, elle m'a dit que j'avais un tennis elbow. Je n'ai jamais fait ça. Par contre, très souvent, il faut aller voir ce qui se passe sur le plan pulmonaire ou viscéral. Et en fait, il faut aller réfléchir dans la phase d'organisation du système. Et donc, tu vas juste comprendre. Regardez ce qui se passe ici. Et là, quand tu commences à comprendre où ça se met ici, tu commences à aller traiter le viscéral. Donc, redonner la spirale viscérale pour libérer les membres. Et inversement, pour libérer parfois des problèmes périphériques, c'est ce qu'en médecine chinoise on fait. On va piquer des endroits très précis dans ta périphérie. L'empreinte est toujours présente. Ton péritoine peut régresser dans le temps si c'est nécessaire. Pour réutiliser les fonctions qui avaient été à un moment donné présentes. Tout l'ensemble de nos grosses blessures de vie se font avant 5 ans. Abandon, rejet, injustice, nini, nana. Certains trucs se font même dans la phase embryonnaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui se passe ici peut s'exprimer dans les reflets qui se passent ici. J'ai besoin de ce cellulome ici et de mon tube neural. Et il y a un angle qui est ici. Et c'est là où il va y avoir comme un champ d'aspiration. C'est un niveau un peu plus spécifique. J'ai ici un champ métabolique. Qui est ici avec un champ de restriction. Et là un champ d'hypercroissance. Ça va faire tout de suite un mouvement. Une petite palette ici. Comme ici, ça ne pousse pas, ça fait ça. C'est par cet angle ici. Et en fait c'est

lié à l'angle avec mon cellulome et mon tube neural qui est derrière. Je vois que j'ai une angulation avec mon tube neural et mon cellulome. Que là j'ai un champ de restriction. De la veine cardinale, j'ai une veine qui va pousser. Je vais avoir un champ de nourriture plus importante et un frein. Et ici j'ai une accélération et là j'ai moins. Et par ce biais là, ça va grandir et ici ça grandit moins vite. Et le fait que j'ai cette vitesse de croissance différentielle donnée par le système vasculaire va amener en fait un champ d'activation. Ça veut dire qu'on dit cette phrase-ci. Le métabolisme très actif va provoquer un flux puissant dans le tissu mésenchymateux. Ce qui va entraîner une croissance. Une croissance du système de canalisation et qui va améliorer le métabolisme mésenchymateux. Cette induction va provoquer une croissance suivie du tissu ectodermique. Donc c'est d'abord mon plan mésodermique qui va s'induire. C'est lié à ce champ vasculaire. La main n'apparaît pas en dernier, elle apparaît en premier. Donc d'abord ta main et puis c'est le système qui s'allonge. On va prendre cette main là comme le point de descente. J'inverse mon point de référence. Première grande articulation. C'était la flexion de mon embryon. Cette flexion de mon embryon c'est la vitesse de croissance par rapport à mon aorte. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je fléchis. Mais si tu regardes, toutes les articulations suivent le même protocole. Pourquoi ça va vers l'intérieur ? Parce que j'ai mon artère depuis ma veine cardinale qui va donner une branche dans un flux trophique ici qui va être l'ébauche de mon système brachio-céphalique. Je vais faire ça. Et je vais venir vers ici. Là ça pousse plus vite. Et donc je fais ça vers l'avant. Si je fléchis comme ça, je vais fléchir ici parce que là j'ai un vaisseau, là je n'en ai pas. Comme je n'en ai pas, ça va se densifier, ça va faire les crânes. Mais ce n'est pas parce que j'ai les crânes que je ne sais pas aller par là. C'est parce que je n'avais pas de vaisseau. Le schéma c'est que je m'enroule autour de mon système vasculaire. Donc c'est un mouvement d'abord

de rotation externe. Suivi d'un mouvement de contre-rotation par mon champ vasculaire, de contre-rotation interne. Un, deux. Et l'inverse pour mes membres. C'est mon sommite, petit à petit ici avec le champ vasculaire qui va soulever l'épiblaste. Il n'y a pas le schéma qui montre ici mais c'est ça qui va donner parce que n'oubliez pas que je vais avoir le myotome, etc. C'est le mésoblaste qui va donner l'induction. Donc ça c'est vraiment du mésoblaste. Donc ça c'est vraiment du mésoblaste. C'est le méso qui va pousser. Donc mes membres c'est une expansion du sac cardio-pleuro-péritoneal. Tout ce qui est tendon, tout ce qui est vaisseau vont provenir du mésoblaste de la lame latérale. Le traitement d'une lésion des membres implique leur rééquilibration avec le pleuro-péricardio-péritoneal. Traiter un membre c'est le réintégrer dans la cavité abdominothoracique. Tu vas redégager tout le système péritoneal en libérant les membres. L'axe mésentérique, tu te mets sur le système et tu libères tout le péritone dans sa phase de rotation sur l'axe. Là tu as plus d'émergence ici pour les membres supérieurs, plus d'émergence ici pour les membres inférieurs. Je prends la main parce que c'est l'émergence. C'est comme si je tire sur la tirette et je me mets sur l'axe postérieur ici. Ça fait un mouvement comme ceci d'abord et puis ça fait ceci à la fin. Je me mets sur l'axe vasculaire. Du ilge que sur l'endothélium. L'endothélium c'est le péritone des vaisseaux. Là on voit qui explique l'axe médian, toute la métamérisation. Tu vois cette rotation externe de mes membres. Et puis à un moment donné l'épaule fait bien ce mouvement et puis ça fait ça. Même chose pour les membres. Au départ c'est mis comme ça. Et puis par ce mouvement de battement, tu vas retrouver une autre disposition de ta segmentation. Si je le remets dans le mouvement en trucs, je vais juste me retrouver avec une cartographie très simple. Qui paraissait ici, je veux dire en S1 ou en S2, va se retrouver avec ces autres lignes qui vont se définir par rapport à ces lignes. Toute la

disposition métamérique neuronale qui va se redistribuer par ces schémas. N'oubliez pas que chaque métamère, 1 organisée par mon vaisseau, 2 cette crête neurale qui vient en tour, qui donne cette organisation. Chaque vertèbre correspond finalement à peu près à un organe ou quelque chose comme ça. Mais je préfère l'idée de Jarico. Plusieurs dermalgies vertèbres, une dermalgie organe. Donc vous avez l'angle de l'ouïe. Juste en dessous, tu vois, tu as une dermalgie au niveau de D8 qui correspond au foie. Juste en dessous tu as une autre, un peu plus bas ici, qui va correspondre au centre pylorique. Puis là, tu as la vesicule biliaire. Et là, tu as le pancréas. C'est cette ligne-ci qui m'a fort intéressé avec les reins qui sont pris ici. Quand je prends, je sais où je suis. 1, j'ai la côte. En même temps, la plèbe pariétale avec la contre-rotation au niveau de ma plèbe viscérale. Au niveau de mes extrémités, il y a une induction du cellulome. L'induction du cellulome est l'orientation par le champ vasculaire. On voit bien la petite palette de la main, la croissance ici, de plus en plus grande. On voit bien que ça vient se terminer vers le cœur avec l'information centrifuge, centripète donnée par le rythme cardiaque. Mouvement inverse au niveau des membres inférieurs. C'est une rotation interne avec une contre-rotation comme l'autre. Comme ici, ça fait un mouvement comme ça. Et pas oublier ce mouvement là. Et c'est l'inverse au niveau de mes membres. Un mouvement et finalement ça va se retrouver comme ça. Mais ça fait d'abord avec l'ouverture ici. Et ça suit mon champ vasculaire. Dans la croissance ici de l'embryon, c'est l'os qui est actif et c'est le muscle qui est passif. C'est un jeu entre l'étiration du champ de dilation et la croissance de l'os. C'est pour ça que si on va sur son fulcrum, on va rechercher l'os dans le fluide, puisqu'au départ c'est du fluide. Quand tu vois un iliac, il est fait de trois parties, l'ilium, l'ischium et le pubis. La forme de l'os, à un moment donné, sera liée à ce champ de dilation. L'os est le moteur et puis, tu vois au départ, quand tu vois les petits os de bébé,

le moteur est là et puis après ça change. C'est le muscle qui prend son activité. Et c'est là que la forme commence à se définir dans sa précision. Je vais tirer sur un petit truc comme ça. Ça c'est la grande spirale de développement de mes membres, mes membres supérieurs, inférieurs, et l'organisation de mon péricarpe. Ça c'est la contre-rotation. Le mouvement embryonnaire, c'est un mouvement, comme ceci, c'est l'inverse, ça c'est la contre-rotation. La base du crâne dérive du mésenchyme para-axial. La face, les mailles, les dentaires dérivent de la crête neurale. La colonne vertébrale et les côtes dérivent du mésenchyme para-axial. Le squelette des membres dérive de la somatopleure, laquelle vont former les bourgeons des membres. Ce qu'on retient, c'est que traiter la face, les dents, implique de les rééquilibrer avec le rhombomère, qui est un bras d'origine. La base du crâne, la colonne, se traite de façon homologue, de la même façon, tandis que toute lésion des membres implique de le traiter avec le pleuro-péricardopéricarpe. Traiter un membre, c'est le réintégrer dans leur cavité péritonéale. Ça c'est une clé par rapport à le fulcrum embryonnaire.